

Tumeurs cutanées épithéliales et mélaniques

Dr Luca Campedel¹, Pr Bernard Dubray², Dr Claire Mignard³, Pr Luis Teixeira⁴, Pr Elisa Funck-Brentano⁵

¹Sénopôle Saint Louis, Service d'Oncologie Médicale, Hôpital Saint Louis, AP-HP, Paris

²Département de Radiothérapie et Physique Médicale, Centre Henri-Becquerel, Rouen

³Département de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Rouen

⁴Sénopôle Saint Louis, Service d'Oncologie Médicale, Hôpital Saint Louis, AP-HP, Paris

⁵Service de Dermatologie Générale et Oncologique, Hôpital Ambroise Paré, AP-HP, Boulogne-Billancourt, Collège des enseignants en dermatologie de France (CEDEF)

OBJECTIFS : N° 302. Tumeurs cutanées épithéliales et mélaniques

→ Diagnostiquer une tumeur cutanée, épithéliale ou mélanique.

1. Tumeurs épithéliales bénignes à HPV

- 1.1. Définition
- 1.2. Épidémiologie
- 1.3. Physiopathologie, histoire naturelle
- 1.4. Diagnostic
- 1.5. Évolution, pronostic
- 1.6. Diagnostics différentiels
- 1.7. Approches thérapeutiques
- 1.8. Suivi

2. Carcinomes cutanés

- 2.1. Carcinomes épidermoïdes cutanés (carcinomes spinocellulaires)
- 2.2. Carcinomes basocellulaires

3. Tumeurs mélaniques bénignes : nævus

- 3.1. Physiopathologie
- 3.2. Formes cliniques

3.3. Facteurs de risque

- 3.4. Évolution, pronostic
- 3.5. Diagnostics différentiels
- 3.6. Approches thérapeutiques
- 3.7. Suivi

4. Tumeurs mélaniques malignes : mélanomes

- 4.1. Définition
- 4.2. Épidémiologie
- 4.3. Physiopathologie, histoire naturelle
- 4.4. Diagnostic
- 4.5. Facteurs de risque
- 4.6. Évolution, pronostic
- 4.7. Diagnostics différentiels
- 4.8. Bilan d'extension
- 4.9. Suivi et prévention

Rang	Rubrique	Intitulé
A	Définition	Connaître les principales tumeurs cutanées
A	Diagnostic positif	Connaître la présentation clinique d'une tumeur épithéliale bénigne à HPV
B	Épidémiologie	Connaître l'épidémiologie des tumeurs cutanées
A	Prise en charge	Connaître les principes de la prise en charge globale des tumeurs cutanées
A	Diagnostic positif	Connaître la présentation clinique et la démarche diagnostique devant un carcinome basocellulaire, épidermoïde
B	Suivi et/ou pronostic	Connaître le pronostic des carcinomes basocellulaires et épidermoïdes
A	Prise en charge	Connaître la prévention des carcinomes épidermoïdes et basocellulaires
A	Définition	Connaître la définition et les principaux facteurs de risque des nævi
B	Diagnostic positif	Connaître les diagnostics différentiels des nævi
B	Physiopathologie	Connaître la physiopathologie des nævi
A	Diagnostic positif	Connaître les signes cliniques du mélanome
B	Suivi et/ou pronostic	Connaître l'évolution et le pronostic du mélanome

A	Prise en charge	Connaître les modalités de prévention du mélanome
B	 Contenu multimédia	Photographie d'une lésion précancéreuse cutanée
B	 Contenu multimédia	Photographie d'un carcinome basocellulaire
B	 Contenu multimédia	Photographie d'un carcinome épidermoïde
A	 Contenu multimédia	Photographie d'un mélanome



Les situations de départ sont indiquées en violet et gras dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

- La plupart des tumeurs cutanées se développent aux dépens des kératinocytes et des mélanocytes de l'épiderme. Seules seront abordées dans cet item les tumeurs épithéliales bénignes (verrues à HPV) et malignes (carcinomes épidermoïdes cutanés et carcinomes basocellulaires) et les tumeurs mélanocytaires bénignes (naevus) et malignes (mélanomes).
- Toutes ces tumeurs, sauf les verrues à HPV, partagent un facteur de risque commun, l'exposition au rayonnement ultraviolet (UV).
- Pour ce qui est des tumeurs malignes, les tumeurs épithéliales sont de loin les plus fréquentes, avec en chef de file le carcinome basocellulaire qui est même la tumeur humaine la plus fréquente, et en général de bon pronostic. À l'inverse, le mélanome, quand il devient métastatique, a un pronostic sombre qui a toutefois été significativement amélioré par les nouvelles thérapies : thérapies ciblées inhibant BRAF V600E/K et MEK et les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (anti-CTLA4 et anti-PD-1).

Pour comprendre : les UV sont définis en UV A/B/C en fonction de leur longueur d'onde (de la plus longue à la plus courte, de A à C). Via des mécanismes différents, directs ou indirects, ces trois types d'UV peuvent être responsables de lésions cutanées bénignes ou malignes **liées à la photoexposition**. Ils ne seront donc pas différenciés par la suite.

A 1. Tumeurs épithéliales bénignes à HPV (verrues et condylomes)

1.1. Définition

- Elles correspondent aux lésions dues à HPV (*Human papillomavirus*) dont il existe plus de 120 génotypes différents. Elles peuvent survenir sur la peau (verrues) ou les muqueuses (condylomes), et ont un risque de transformation cancéreuse possible (notamment pour les lésions muqueuses).

1.2. Épidémiologie

- La prévalence des verrues est de 7 à 10 % de la population générale (enfants scolarisés et adultes jeunes).
- Certains contextes professionnels favorisent les verrues des mains causées par HPV7 (bouchers, vétérinaires, personnels des abattoirs, poissonniers).
- Les infections cutanées à HPV sont plus fréquentes et plus agressives en cas d'immunodépression au long cours (patients greffés d'organe).

1.3. Physiopathologie, histoire naturelle

- La transmission virale se fait par contact direct. Les HPV infectent les kératinocytes de la couche basale, qui se transforment en koïlocytes (aspect cytopathogène), après rupture de la barrière cutanée lors d'un micro-traumatisme local. Les HPV ont un tropisme exclusif pour les épithéliums malpighiens, dont l'épithélium cutané.
- Le virus peut persister à l'état latent (infection latente, porteur sain).
- Risque oncogène : le plus souvent co-carcinogènes avec les UV, le tabac, l'immunosuppression (transplantés, VIH). Les HPV muqueux à risque oncogène peuvent être directement carcinogènes (HPV 16, 18, 31, 33).

1.4. Diagnostic

- Le diagnostic est clinique et il n'est en aucun cas nécessaire de réaliser une biopsie en cas de lésion typique.
- Il existe différents types de verrues :
 - **les verrues plantaires.** On distingue :
 - la myrmécie liée à HPV1, la plus fréquente, profonde, douloureuse spontanément et à la pression, circonscrite par un anneau kératosique dont la surface de la zone centrale est le siège de micro-hémorragies (ponctuations noirâtres), unique ou multiples ;
 - ou les verrues en mosaïque, liées à HPV2, superficielles, moins fréquentes et non douloureuses, formées de multiples verrues regroupées en un placard kératosique moins épais. La coexistence de ces deux types de lésions est exceptionnelle.
 - **les verrues vulgaires** : uniques ou multiples, infracentimétriques, sous forme d'élevures hémisphériques ou aplaties avec saillies villeuses kératosiques, situées le plus souvent sur la face dorsale des mains et des doigts et dues à HPV2. L'atteinte péri-unguéale ou sous-unguéale entraîne des douleurs et une dystrophie unguéale ;
 - **les verrues planes communes**, dues à HPV3, sous forme de papules roses, jaunes, brunes ou chamois, à surface lisse, siégeant le plus souvent sur le visage, mais aussi sur le dos des mains et sur les membres.

1.5. Évolution, pronostic

- Les verrues à HPV peuvent persister plusieurs années, mais, dans la plupart des cas, elles disparaissent spontanément en un à deux ans. Les récurrences sont fréquentes, en raison de l'auto-inoculation.

1.6. Diagnostics différentiels

- Les principaux diagnostics différentiels à évoquer sont :
 - durillon, également appelé « cor », qui est un épaissement de la couche superficielle de la peau lié aux frottements, qui contrairement aux verrues garde l'aspect de la peau avoisinante (architecture en lignes cutanées) ;
 - une autre tumeur cutanée : penser au mélanome achromique de la plante des pieds ; carcinome épidermoïde *in situ* à évoquer en cas de lésions sous ou péri-unguéales persistantes (biopsie au moindre doute).

1.7. Approches thérapeutiques

Il n'existe pas de moyen d'éradiquer le virus HPV. Les papillomavirus humains (HPV) sont retrouvés de façon ubiquitaire dans les tissus épithéliaux humains.

- Pas de traitement spécifique des infections à HPV.
- L'objectif d'un traitement est la disparition des lésions macroscopiquement visibles.
- Il faut informer le patient du risque de récurrence (environ 30 %) : persistance de l'HPV dans la peau saine.
- Le plus souvent, les verrues régressent spontanément, ainsi le traitement ne doit pas être trop agressif, en particulier chez les enfants.
- Les traitements curatifs comprennent :
 - destruction chimique par kératolytiques (préparations à base d'acide salicylique), simple et non douloureuse ;
 - cryothérapie (azote liquide) ;
 - laser CO₂ (sous anesthésie locale, peut laisser une cicatrice).
- Le traitement préventif comprend la limitation de la diffusion par application de vernis incolore sur les verrues les jours de piscine ou de séances de sport fait pieds nus ; les soins d'hygiène dans les familles dont un membre est atteint (serviette de toilette individualisée).

1.8. Suivi

- Pour les patients immunodéprimés, une surveillance dermatologique annuelle est préconisée.

A 2. Carcinomes cutanés

- Les cancers épithéliaux de la peau se développent à partir des kératinocytes de l'épiderme. Ce sont les cancers les plus fréquents dans les deux sexes (homme > femme). Ils représentent 90 % des cancers cutanés et leur incidence est en augmentation constante. Ils surviennent préférentiellement chez les sujets de plus de 60 ans (l'âge étant un facteur de risque) et sur les zones exposées au soleil ; en effet l'exposition aux UV est le principal facteur de risque extrinsèque de la carcinogénèse épithéliale (avec une expression clinique retardée de 30 à 40 ans).

2.1. Carcinomes épidermoïdes cutanés

2.1.1. Définition

- Les carcinomes épidermoïdes cutanés correspondent à une prolifération de cellules kératinocytaires de grande taille, organisées en lobules ou en travées, de disposition anarchique.

B 2.1.2. Épidémiologie

- Les carcinomes épidermoïdes apparaissent le plus souvent après 60 ans. L'âge moyen de découverte est de 76 ans. L'incidence annuelle en France est estimée à 30/100 000 dans la population générale.

A 2.1.3. Physiopathologie, histoire naturelle

- La plupart du temps, le carcinome épidermoïde se développe à partir d'une lésion précancéreuse (appelée précurseur) cutanée ou muqueuse, mais peut également survenir *de novo*. On distingue le carcinome intra-épithélial ou carcinome *in situ* (appelé aussi maladie de Bowen) qui est une forme non invasive, sans franchissement de la membrane basale et donc sans risque de métastase, du carcinome épidermoïde cutané primitif invasif qui est à risque de métastase.

2.1.3.1. Lésions précancéreuses cutanées (ou précurseurs cutanés)

- Les **kératoses actiniques** se développent sur les zones photoexposées (front, tempes, scalp chauve, pavillon des oreilles, dos des mains et des bras) (**Figure 1**). Il s'agit de lésions kératosiques ou croûteuses (rugueuses à la palpation) multiples mal limitées, érythémateuses ou chamoisées, saignant facilement après grattage. L'évolution peut se faire selon trois modalités : la disparition spontanée, la persistance ou la progression vers un carcinome épidermoïde cutané. La présence de kératose actinique est un facteur de risque de cancer cutané, mais le risque de transformation est limité.
- Le **champ de cancérisation** correspond à une zone anatomique comprenant de multiples kératoses actiniques pouvant être associées à des carcinomes cutanés.

Figure 1. Contenu multimédia. Kératose actinique typique

(Photographie fournie par le Dr Charlotte Fite, Service de Dermatologie, Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph).



- Les signes de cancérisation sont l'apparition d'un bourrelet induré, d'une ulcération, d'une rougeur excessive ou d'une kératinisation en corne. Toute modification d'une kératose actinique impose une biopsie ou l'exérèse chirurgicale.

2.1.3.2. Lésions précancéreuses muqueuses (ou précurseurs muqueux)

- Les **leucoplasies** sont des lésions blanchâtres bien limitées, asymptomatiques, adhérentes et ne saignant pas au contact. Elles correspondent à une kératinisation de la muqueuse, en particulier labiale, due au tabac et aux UV.

2.1.3.3. Maladie de Bowen

- La **maladie de Bowen** est un carcinome épidermoïde intra-épithélial (*in situ*).
- L'aspect est celui d'une plaque rouge, bien limitée, à contours nets et irréguliers, recouverte de fines squames. La lésion s'élargit lentement. Les localisations sont multiples dans un tiers des cas et peuvent être cutanées (préférentiellement en zone photo-exposées) ou muqueuses (vulve et gland). Sur le gland on parlera d'érythroplasie de Queyrat, dont l'aspect est celui d'une lésion érythémateuse rouge vif, bien limitée parfois discrètement érosive ; chez la femme, la lésion est souvent unique, plane ou peu infiltrée, rosée avec des plages pigmentées. En cas d'infiltration ou ulcération franche, il faut évoquer une lésion invasive. La fréquence de la progression vers un carcinome épidermoïde cutané n'est pas connue avec précision.

2.1.4. Diagnostic

- Les carcinomes épidermoïdes cutanés siègent préférentiellement au niveau des zones photo-exposées (tête, cou, dos des mains et des bras). Un examen clinique de l'ensemble du revêtement cutané (peau+muqueuse) est cependant indispensable à la recherche d'autres lésions cancéreuses ou précancéreuses, en particulier chez les patients immunodéprimés.
- L'aspect est celui d'une tumeur bourgeonnante, indurée, saignant facilement, avec un centre ulcéré recouvert de croûtes (**Figure 2**) mais la lésion peut également être végétante ou bourgeonnante. En cas de kératose ou de maladie de Bowen préexistante, la survenue d'un cancer épidermoïde cutané primitif invasif est suspectée devant une ulcération, une surélévation, une induration ou un saignement.
- Dans tous les cas, une analyse anatomo-pathologique est indispensable au diagnostic.

Figure 2.  Contenu multimédia. Carcinome épidermoïde ulcéré



2.1.5. Facteurs de risque

- Le principal facteur de risque est la dose d'UV reçue au cours de la vie (expliquant en partie la survenue dans les zones découvertes et chez des patients âgés), avec une susceptibilité particulière en cas de phototype cutané clair.
- Dans certains cas, le développement de carcinomes épidermoïdes des muqueuses peut être lié à HPV (col de l'utérus, organes génitaux externes masculins et féminins, anus, oropharynx).
- Il existe d'autres facteurs de risque comme l'immunodépression (après greffe d'organe ++++), certaines maladies génétiques, certaines maladies inflammatoires, les plaies chroniques, certains carcinogènes chimiques (arsenic...).

Pour comprendre : la classification des phototypes de Fitzpatrick, qui ne sera pas détaillée, définit 6 types de phototypes, le type 1 le plus clair correspondant à un individu qui ne bronze pas, attrape systématiquement des coups de soleil, a la peau très claire avec des taches de rousseur et des cheveux blonds ou roux.

B 2.1.6. Évolution, pronostic

- L'évolution peut se faire :
 - par voie locale (infiltration) ;
 - par voie ganglionnaire, ce qui implique un examen clinique systématique des aires ganglionnaires de drainage (qui sera complété par une échographie ganglionnaire en cas de forme agressive, terrain particulier à risque ou de signe clinique d'extension loco-régionale). Cela concerne 2 % des formes cutanées et 20 % des formes muqueuses ;

- par voie hématogène, et donner des métastases à distance vers d'autres organes (poumons+++, foie, os, ganglions à distance, etc.), plus fréquemment dans le cas de carcinomes épidermoïdes muqueux
- Il existe également un risque de récurrence locale après traitement à visée curative.
- Les facteurs de risque d'évolution péjorative sont :
 - les localisations : péri-orificielles du visage (nez, lèvres, oreille, paupières), les tempes, le cuir chevelu, les muqueuses ; sur peau pathologique : radiodermite, cicatrice de brûlures, plaies chroniques (ulcères, escarres, etc.) ;
 - la taille de la tumeur, surtout si > 2 cm (> 1 cm pour les zones péri-orificielles) ;
 - le degré d'invasion locale : adhérence au plan profond ; envahissement péri-nerveux et/ou osseux ; embolies vasculaires ;
 - l'épaisseur tumorale histologique > 3 mm ;
 - le degré de différenciation cellulaire en histologie : moyen à indifférencié ;
 - la récurrence locale ;
 - l'immunodépression (notamment greffe d'organe).

A 2.1.7. Diagnostics différentiels

- Ils sont représentés par les autres tumeurs cutanées et la kératose actinique. Au moindre doute, une biopsie sera réalisée.

2.1.8. Bilan d'extension

- À l'examen clinique, on contrôle la mobilité par rapport au plan profond et on mesure le diamètre de la lésion. De plus, on recherche d'autres tumeurs cutanées telles que d'autres carcinomes et/ou mélanomes sur l'ensemble du tégument. Enfin, on recherche une adénopathie dans le territoire de drainage.
- Le plus souvent, aucun bilan d'extension par examen d'imagerie complémentaire n'est nécessaire. Toutefois, en cas de forme agressive, un terrain à risque particulier (immunodépression) ou un signe clinique d'extension loco-régionale, un bilan à la recherche de métastases loco-régionales par échographie ganglionnaire du territoire de drainage est indiqué. En cas d'atteinte ganglionnaire avérée, un bilan d'extension à la recherche de métastases à distance par scanner thoraco-abdominal ou TEP-TDM est recommandé.
- En cas d'adénopathie suspecte à l'échographie, une confirmation histologique est nécessaire.
- Une évaluation globale du patient est indispensable chez les patients très âgés, fragiles ou avec des co-morbidités (état général, autonomie, comorbidités, troubles cognitifs, entourage), justifiant chez ces patients une consultation d'oncogériatrie avant toute décision thérapeutique.

B 2.1.9. Traitement des carcinomes épidermoïdes cutanés localisés

- Les décisions thérapeutiques sont validées en RCP, idéalement complétée par une consultation conjointe (dermatologue, chirurgien, oncologue radiothérapeute). Dans tous les cas, l'information du patient doit précéder la prise en charge lors d'une consultation d'annonce (difficulté en cas de troubles cognitifs).
- Une biopsie préalable au traitement est nécessaire si le diagnostic est incertain ou avant un traitement chirurgical complexe.
- L'exérèse chirurgicale avec des marges adaptées au groupe pronostique est le traitement de première intention, avec examen anatomopathologique de la pièce opératoire. Toute exérèse incomplète ou « limite » doit être reprise (si patient opérable à nouveau).
- Les alternatives thérapeutiques à la chirurgie concernent :
 - les patients inopérables ou en cas de localisations délabrantes après biopsie de confirmation et validation en RCP, où l'on peut proposer une radiothérapie (radiothérapie externe ou curiethérapie) ;
 - les carcinomes épidermoïdes *in situ* (ou maladie de Bowen), où l'on peut proposer des traitements topiques par photothérapie dynamique ou imiquimod.

B 2.1.10. *Suivi et prévention*

- La majorité des patients traités pour un carcinome épidermoïde cutané localisé est guérie par le traitement.
- Le suivi repose sur un examen clinique régulier pour dépister une récurrence locale ou ganglionnaire, un nouveau carcinome épidermoïde cutané ou carcinome basocellulaire, ou encore un mélanome. Les lésions pré-cancéreuses dépistées (kératoses actiniques, lésions virales HPV-induites) doivent être traitées.
- Les patients immunodéprimés (greffe d'organes) sont suivis à vie.
- Il est important d'informer les patients sur ces risques de récurrence ou de nouveaux cancers cutanés et de les éduquer à l'autosurveillance/autodépistage ainsi que leur remettre les conseils de prévention solaire.
- Les conseils de prévention solaire reposent tout d'abord sur des stratégies d'évitement solaire (en évitant les expositions entre 12 heures et 16 heures, mettre des vêtements couvrants et un chapeau, privilégier les activités à l'ombre), en déconseillant l'usage des lampes à bronzer.
- L'application d'écran solaire est utile, de façon ponctuelle afin d'éviter un coup de soleil, mais ne doit pas permettre une augmentation du temps d'exposition solaire.
- La prévention doit être enseignée à tous en ciblant prioritairement les sujets de phototype clair, ceux avec des multiples expositions solaires professionnelles ou récréatives. De plus, il est important de limiter l'exposition solaire particulièrement pendant l'enfance et l'adolescence.

A 2.2. Carcinomes basocellulaires

2.2.1. Définition

- Le carcinome basocellulaire est formé d'amas cellulaires kératinocytaires issus de la zone basale ou des follicules pileux.

B 2.2.2. *Épidémiologie*

- **Le cancer basocellulaire de la peau est la tumeur humaine la plus fréquente dans les deux sexes.** Il représente près de 30 % de l'ensemble des cancers. Il survient dans la plupart des cas après 50 ans. À l'instar des carcinomes épidermoïdes, la prise en charge des cancers basocellulaires chez les personnes (très) âgées peut être très complexe (comorbidités, troubles cognitifs).

A 2.2.3. *Physiopathologie, histoire naturelle*

- À la différence des carcinomes épidermoïdes, il n'existe pas de précurseur ou lésion précancéreuse.

2.2.4. Diagnostic

- La lésion typique est une papule en zones photo-exposées. **Le carcinome basocellulaire n'atteint jamais les muqueuses.**
- En relief par rapport à la peau avoisinante, cette papule rosée a un aspect translucide imitant une perle avec de fines télangiectasies. Souvent, une fine croûte recouvre l'ulcération néoplasique, qui saigne après son ablation. Dans les formes ulcéro-bourgeonnantes, on trouve sur le bourrelet périphérique un aspect perlé caractéristique.
- Les variantes cliniques sont multiples :
 - le **carcinome basocellulaire nodulaire**, forme la plus fréquente, qui prend la forme d'une papule translucide ferme, bien limitée, lisse, perlée et recouverte de télangiectasies (**Figure 3**) ;
 - le **carcinome basocellulaire sclérodermoïde** a un aspect de cicatrice fibreuse blanchâtre indurée, parfois atrophique, aux limites imprécises. L'extension profonde et en surface est plus importante que la partie visible ;
 - le **carcinome basocellulaire superficiel** est une plaque érythématosquameuse plane, bien limitée, bordée de perles en périphérie.

Figure 3.  Contenu multimédia. Carcinome basocellulaire



2.2.5. Facteurs de risque

- L'exposition solaire courte, intense et répétée, plutôt que l'exposition chronique.
- Le phototype clair.
- Certaines maladies génétiques sont associées à la survenue de carcinomes basocellulaires cutanés (*xeroderma pigmentosum*, syndrome de Gorlin).

B 2.2.6. Évolution, pronostic

- L'évolution spontanée se fait par extension loco-régionale, avec destruction des structures anatomiques de voisinage. Les récidiives après traitement sont possibles, notamment dans les formes sclérodermiiformes ou mal limitées. Les carcinomes basocellulaires ne métastasent qu'exceptionnellement au niveau ganglionnaire ou viscéral (pas de bilan d'extension).
- Les facteurs de mauvais pronostic sont la localisation céphalique (nez, zones péri-orificielles), les formes mal limitées (sclérodermiiforme ou infiltrant), le diamètre > 2 cm (ou > 1 cm sur le nez ou les zones péri-orificielles), le caractère récidivant.

A 2.2.7. Diagnostics différentiels

- Les diagnostics différentiels sont représentés par les autres tumeurs cutanées. Les formes sclérodermiiformes peuvent être confondues avec une atrophie cicatricielle, et les formes superficielles avec une plaque de psoriasis (item 117) ou une dermatophytose (item 155). Au moindre doute, une biopsie devra être réalisée.

2.2.8. Bilan d'extension

- Le bilan d'extension est uniquement clinique, à la recherche d'autres localisations de carcinomes cutanés. **Aucun examen complémentaire systématique n'est nécessaire.**
- Lorsqu'elle est possible, la chirurgie est le traitement de choix. Les médicaments ciblant la voie Hedgehog peuvent être d'une efficacité remarquable dans les formes très évoluées.

Il n'y a jamais d'extension métastatique dans ce type de tumeurs.

B 2.2.9. Suivi

- Le suivi repose sur un examen clinique de dépistage de récurrence ou de survenue d'autres cancers cutanés. La fréquence des examens de dépistage varie selon la présence de facteurs de risques, au mieux elle sera à vie.
- Le patient doit être formé à l'autodépistage et consulter en cas d'apparition d'une nouvelle lésion ou d'une lésion qui ne guérit pas.
- La prévention primaire repose sur la prévention solaire avec des mesures d'évitement solaire (horaires, ombres, vêtements couvrants et chapeau) pour limiter l'exposition aux UV (naturels et artificiels) et la protection solaire en complément.
- Le **Tableau 1** synthétise les caractéristiques comparées du carcinome épidermoïde cutané et du carcinome basocellulaire.

A

Tableau 1. CARACTÉRISTIQUES COMPARÉES DU CARCINOME ÉPIDERMOÏDE ET DU CARCINOME BASOCELLULAIRE		
	Carcinome épidermoïde cutané	Carcinome basocellulaire
Lésions précancéreuses	Oui Cutanées : kératose actinique, Maladie de Bowen Muqueux : leucoplasies	Non
Localisation	Cutanée ou muqueuse	Uniquement cutanée
Présentation clinique	Lésion ulcéro-bourgeonnante, parfois croûteuse Infiltrante	Éléments sémiologiques : perle, télangiectasies Formes : nodulaire, superficielle, sclérodermiforme
Diagnostic différentiel	Kératose actinique, autres tumeurs cutanées	Autres tumeurs cutanées, psoriasis, dermatophytose
Évolution	Risque métastatique : territoire de drainage lymphatique puis à distance	Pas de métastase (exceptionnel) Évolutive loco-régionale, infiltrante, délabrante
Facteurs de mauvais pronostic	Localisation : cicatrice, ulcère, extrémité céphalique (tempes, oreilles, lèvres), Taille : > 2 cm CE récidivant ou marges chirurgicales atteintes Épaisseur > 6 mm ou invasion au-delà de la graisse sous-cutanée Envahissement périnerveux et/ou osseux Faible degré de différenciation Forme desmoplastique Terrain : immunodépression	Localisation : extrémité céphalique, en particulier nez et zones péri-orificielles Formes sclérodermiformes, mal limitées Taille : > 1 cm dans les zones à risque > 2 cm dans les autres zones CBC récidivant
Traitement commun au stade localisé	Exérèse chirurgicale avec marges de sécurité	
Surveillance	Recherche d'une récurrence locale, loco-régionale (ganglionnaire) puis à distance (poumon, foie essentiellement) Recherche d'un autre carcinome ou mélanome	Recherche d'une récurrence locale Recherche d'un autre carcinome ou mélanome
Prévention commune	Réduction de l'exposition solaire, photoprotection (vêtements couvrants, chapeau, écran solaire), éducation à l'auto-surveillance/autodépistage	

A 3. Tumeurs mélaniques bénignes : nævus

3.1. Physiopathologie

- Les nævus correspondent à une prolifération ou une accumulation de mélanocytes normaux en situation anormale : ce sont des tumeurs bénignes. À l'état basal, les mélanocytes, situés entre les kératinocytes de la jonction dermo-épidermique, sont chargés de fabriquer la mélanine, pigment protecteur des rayonnements ultraviolets transféré aux kératinocytes via des dendrites. Les cellules mélanocytaires se regroupent en amas ou thèques, pour former les nævus, qui peuvent être jonctionnels (couche basale de l'épiderme), dermiques ou mixtes.

3.2. Formes cliniques

- Les nævus sont des lésions bénignes mélanocytaires congénitales ou acquises. L'aspect clinique est très variable.

3.2.1. Nævus communs acquis

- On distingue deux types cliniques :
 - les nævus pigmentés bruns plans (nævus jonctionnels) ou légèrement bombés à surface lisse ou rugueuse, voire verruqueuse (nævus composé ou dermique) ;
 - les nævus tubéreux peu ou pas pigmentés, lisses ou verruqueux (nævus mixtes ou dermiques), siègent plutôt sur le visage.

3.2.2. Nævus selon leur pigmentation

- Certains nævus ont une couleur bleutée en raison d'une localisation profonde du pigment mélanique dans le derme. Le nævus bleu est le plus fréquent, il apparaît sous la forme d'une lésion plane ou en relief le plus souvent à l'âge adulte sur le visage ou à la face d'extension des membres supérieurs.
- Certains nævus sont achromiques ; ils ne sont pas pigmentés et ont une couleur de peau normale. Ils sont le plus souvent tubéreux.

3.2.3. Nævus congénitaux (présents à la naissance)

- Ils touchent moins de 1 % des nouveau-nés, à type d'hamartomes pigmentaires le plus souvent. Ils peuvent dans de rares cas être de grande taille (par définition > 20 cm à l'âge adulte).
- La tache bleue mongolique est une forme de nævus bleu congénital. Il est très fréquent, notamment dans les populations asiatiques, plus rares chez les caucasiens (1 %). Elle se présente sous la forme d'une tache ardoisée en région lombo-sacrée. Elle disparaît classiquement dans l'enfance.
- Le nævus d'Ota se situe dans le territoire des deux branches supérieures du trijumeau.

3.2.4. Nævus cliniquement atypiques

- Ils sont des caractéristiques proches de celles qui font craindre un mélanome. Ils sont :
 - souvent de grande taille (diamètre > 5 mm) ;
 - de couleur rosée et/ ou brune ;
 - et présentent une ou plusieurs caractéristiques de mélanome (ABCD).
- Histologiquement, ils sont de type fonctionnels et souvent décrits à tort comme dysplasiques. Il ne s'agit pas de précurseurs de mélanome et l'exérèse systématique n'est pas recommandée.

3.2.5. Nævus multiples

- Le « syndrome des nævus atypiques multiples » est défini par la présence en grand nombre de nævus ($N > 50$), souvent de grande taille (> 5 mm de diamètre), ayant des aspects cliniquement atypiques. Ce syndrome, surtout s'il existe des antécédents familiaux de mélanome, est un facteur de risque important de mélanome (chez les sujets à peau blanche).

3.2.6. Formes topographique de nævus

- Le nævus du lit de l'ongle se présente sous la forme d'une mélanonychie en bande ; le caractère unique et une modification récente doivent faire évoquer un mélanome. Des mélanonychies multiples chez des sujets à peau pigmentée ne correspondent pas à une prolifération mélanocytaire, mais à un simple dépôt de pigment.
- On distingue aussi le nævus des muqueuses et des extrémités.

3.2.7. Remarques

- Il est important de retenir que ni les micro-traumatismes répétés, ni l'exposition solaire ne sont des facteurs de risque de transformation des nævus. En revanche, un nævus qui saigne spontanément doit faire discuter le diagnostic alternatif de mélanome.

3.3. Facteurs de risque

- Le phototype clair, l'exposition solaire et l'immunodépression sont les principaux facteurs favorisant la présence de nævus.

B 3.4. Évolution, pronostic

- L'évolution normale du nævus se fait par une croissance régulière pour atteindre une taille définitive.
- La transformation des nævus en mélanomes est extrêmement rare, sauf pour les nævus congénitaux géants, pour lesquels le risque s'accroît avec la taille de la lésion.

3.5. Diagnostics différentiels

- Ils sont représentés par :
 - les **lentigos**, improprement appelées « taches de vieillesse », qui sont des macules pigmentées sur les zones photoexposées et qui brunissent avec le temps ;
 - les **éphélides** ou « **taches de rousseur** », macules millimétriques brun clair qui apparaissent sur les zones photoexposées chez les individus roux, qui s'accroissent avec le soleil ;
 - l'**histiocytose fibreuse**, tumeur bénigne formée de cellules fibrohistiocytaires, se présentant comme un nodule central ferme entouré d'un halo brunâtre ;
 - une **kératose séborrhéique**, tumeur épithéliale bénigne qui n'évolue jamais vers la malignité, qui apparaît après 40 ans, non liée au soleil, située sur le visage, le décolleté et le dos, dont la couleur va du beige clair au noir, initialement plane puis verruqueuse et rugueuse recouverte d'un enduit squamo-kératosique gras, à bordure nette et abrupte ;
 - un **carcinome basocellulaire nodulaire** ;
 - un **angiome thrombosé** (tumeur vasculaire bénigne) ;
 - surtout, un **mélanome doit être envisagé en cas de caractéristique(s) suspecte(s)**. Au moindre doute, une exérèse doit être pratiquée ; le meilleur facteur pronostique de mélanome étant un diagnostic précoce.

Le traitement et le suivi des nævus ne figurent pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

3.6. Approches thérapeutiques

- L'exérèse des nævus congénitaux à visée esthétique est envisageable et doit se faire le plus rapidement possible, étant plus facile dans les premiers mois de la vie.
- En raison du très faible risque de transformation, il n'y a aucun intérêt à pratiquer l'exérèse systématique des nævus communs, hormis à visée esthétique à la demande du patient.
- Cette exérèse doit se faire avec des marges de 2 mm et la pièce envoyée pour analyse anatomo-pathologique.

3.7. Suivi

- Il n'y a pas d'intérêt à surveiller de manière systématique tous les individus. En revanche, l'auto-surveillance doit être enseignée et encouragée, en s'appuyant sur la règle ABCDE (développée dans le chapitre sur les mélanomes), et une information doit être délivrée sur les risques de l'exposition solaire prolongée.
- Les patients porteurs de plusieurs nævus atypiques ou ayant des facteurs de risque de mélanome doivent bénéficier, en plus de l'auto-surveillance, d'un examen cutané annuel.

A 4. Tumeurs mélaniques malignes : mélanomes

4.1. Définition

- Les mélanomes sont des tumeurs malignes développées aux dépens des mélanocytes.
- L'évolution est, dans un premier temps, horizontale et intra-épidermique, puis, dans un second temps, verticale avec envahissement du derme superficiel (phase micro-invasive), enfin du derme profond et de l'hypoderme (phase invasive).

B 4.2. Épidémiologie

- Le mélanome représente entre 2 et 3 % de l'ensemble des cancers et se situe, en 2023, au 7^e rang des cancers les plus fréquents chez l'homme (9 109 cas attendus) et au 4^e rang chez la femme (8 813 cas attendus).
- L'âge moyen au diagnostic est 68 ans chez l'homme et 62 ans chez la femme. Il affecte tous les âges, mais est exceptionnel chez l'enfant avant la puberté.
- L'incidence est en augmentation régulière depuis 1990 ; les taux d'incidence se rapprochent chez l'homme et chez la femme.
- L'incidence est directement corrélée au phototype et à l'exposition solaire, plus élevée chez les sujets à la peau claire (notamment en Australie), et plus faible dans les pays asiatiques ou dans les populations à la peau noire.

4.3. Physiopathologie, histoire naturelle

- La majorité des mélanomes naissent *de novo* en peau saine, sans précurseur.
- Le risque de transformation maligne des nævus est faible pour les petits nævus communs, et plus élevé pour les nævus congénitaux, notamment lorsqu'ils sont de grande taille (> 20 cm à l'âge adulte). L'exérèse préventive précoce de ces grands nævus est souhaitable (prise en charge médico-chirurgicale spécialisée).

A 4.4. Diagnostic

- Il est extrêmement important de diagnostiquer le mélanome de manière précoce afin d'augmenter les chances de guérison.

Le diagnostic doit être évoqué à l'examen clinique devant la présence d'une lésion pigmentée présentant plusieurs (généralement 3, 4 ou 5) des caractéristiques suivantes (**règle ABCDE**) (**Figure 4**) :

- **A**symétrie
- **B**ords irréguliers
- **C**ouleur inhomogène
- **D**iamètre supérieur à 6 mm
- **E**volution récente

Et le « vilain petit canard » (lésion pigmentée qui ne ressemble pas aux autres)

- L'examen visuel doit être aidé par la dermoscopie, dont l'analyse sémiologique augmente la sensibilité et spécificité diagnostiques.
- Toute suspicion clinique doit faire réaliser l'exérèse (complète si possible) de la lésion afin d'avoir une confirmation histologique du diagnostic. L'analyse de l'ensemble de la lésion permet de déterminer le sous-type du mélanome, et de mesurer les critères histopronostiques qui sont l'épaisseur tumorale maximale selon l'indice de Breslow, la présence ou non d'une ulcération et l'index mitotique, qui vont guider la prise en charge initiale. La biopsie (partielle) est exceptionnelle (lésion de grande taille), car elle peut conduire à des erreurs diagnostiques et ne permet pas d'avoir une bonne évaluation de ces critères notamment de l'indice de Breslow, principale critère histopronostique.

Figure 4.  Contenu multimédia. Mélanome dorsal de type superficiel extensif.



A 4.5. Facteurs de risque et prédisposition génétique

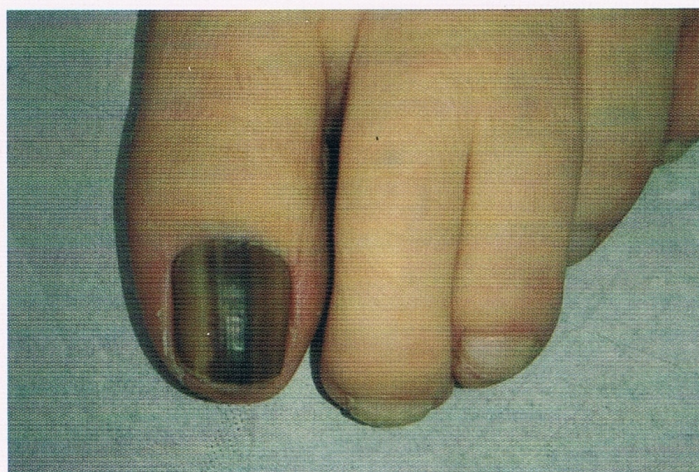
- L'exposition solaire est un facteur de risque environnemental de mélanome :
 - des expositions solaires intermittentes et intenses notamment dans l'enfance (recherche à l'interrogatoire de brûlures solaires) exposent au risque de mélanome superficiel extensif ;
 - l'exposition chronique cumulative tout au long de la vie expose au risque de mélanome de Dubreuilh (qui survient chez des sujets plus âgés) ;
 - cependant, les mélanomes des ongles, des paumes, des plantes et des muqueuses n'ont pas de lien avec les expositions solaires.
- Les marqueurs de risque de mélanome sont :
 - les antécédents familiaux ou personnels de mélanome ;
 - les antécédents personnels de carcinome cutané ;
 - les antécédents d'exposition solaire intense, avec coups de soleil (correspondant à un phototype clair) ;
 - les sujets à peau claire et des cheveux roux ou blonds ;
 - un nombre élevé de nævus/syndrome des nævus atypiques multiples.
- Un contexte familial est retrouvé dans 10 % des mélanomes (défini par deux sujets apparentés au premier degré). On distingue plusieurs gènes de prédisposition au mélanome parmi lesquels *CDKN2A*, gène suppresseur de tumeur muté dans 10 à 30 % des formes familiales et prédisposant également au cancer du pancréas. Des variants du gène *MC1R* (gène du récepteur de la mélanocortine), responsables du phénotype roux sont également associés à un sur-risque de mélanome. Enfin, le syndrome de nævus atypiques est également transmis génétiquement ; il est caractérisé par un grand nombre de nævus ($N > 50$) souvent de grande taille avec des aspects cliniques atypiques (bords irréguliers, polychromie), pouvant être localisés en zone non-photo-exposée (cuir chevelu, fesses, seins chez la femme).

B 4.6. Évolution, pronostic

Le pronostic est extrêmement différent en fonction de la présence ou non d'une atteinte métastatique. La probabilité de survie à 5 ans chute de 88 % pour les formes localisées à 18 % pour les formes métastatiques.

- La classification anatomo-clinique des mélanomes au stade localisé permet de définir le profil évolutif en deux catégories :
 - **les tumeurs avec phase d'extension horizontale.** Elles regroupent :
 - le mélanome superficiel extensif (SSM), le plus fréquent (60-70 % des cas) ;
 - le mélanome de Dubreuilh avec une phase d'extension horizontale pouvant durer plusieurs années (10 % des cas) ;
 - le mélanome acral lentigineux des paumes, des plantes, des bords latéraux des doigts et des orteils, et sous les ongles (2 à 5 % des cas) (**Figure 5**) ;
 - plus rarement, les mélanomes des muqueuses buccales et génitales et le mélanome uvéal (cancer de l'œil le plus fréquent chez l'adulte) ;
 - **les tumeurs sans phase d'extension** horizontale : il s'agit du mélanome nodulaire d'emblée, rapidement invasif (10 à 20 % des cas).

Figure 5. Mélanome unguéal



- **Les critères histo-pronostiques sont :**
 - **l'indice de Breslow** (épaisseur tumorale maximale) principalement, qui fixe la classification par stades : il s'agit du principal critère pronostique avec une corrélation entre la valeur de cet indice et la mortalité.
 - la présence d'ulcération (clinique et/ou pathologique) : valeur péjorative importante quel que soit l'indice de Breslow, et qui garde une valeur péjorative pour les mélanomes avec atteinte ganglionnaire.
 - l'index mitotique : défini par le nombre de mitoses/mm² ; sa valeur pronostique est indépendante pour les tumeurs de faible épaisseur (inférieure à 1 mm), mais elle n'est pas retenue dans la classification TNM en vigueur (AJCC 8^e édition).
 - l'atteinte ganglionnaire : du ganglion sentinelle (ou présence de micrométastase, passage en stade IIIa) ou de macrométastase(s) ganglionnaire(s) (détectées cliniquement ou à l'imagerie) ; le nombre de ganglions atteints, la taille des métastases ganglionnaires, la rupture capsulaire sont des facteurs péjoratifs.

- **L'évolution peut se faire vers :**

- la récurrence locale après exérèse.
- l'évolution métastatique cutanée/sous-cutanée (métastases en transit), ganglionnaire, ou viscérale (tous les organes peuvent être touchés, notamment le cerveau). Les principaux critères de mauvais pronostic au stade métastatique à distance sont le taux de LDH élevé, plus de 3 organes atteints, plus de 3 métastases hépatiques, des métastases cérébrales symptomatiques et/ou plus de 3 métastases cérébrales.

Celle-ci peut être possiblement retardée, même après plusieurs années.

Les traitements adjuvants par thérapie ciblée (pour les mélanomes porteurs d'une mutation BRAF sur le codon V600) ou par immunothérapie par anti-PD-1 ont diminué le risque de récurrence (augmentation de la survie sans récurrence) et d'évolution métastatique (augmentation de la survie sans récurrence à distance).

De plus, le pronostic au stade métastatique à distance s'est nettement amélioré avec ces nouvelles thérapies ciblées (inhibiteurs de BRAF et de MEK) et immunothérapie par anti-PD-1 +/- anti-CTLA-4.

- la survenue d'un deuxième mélanome primitif ou d'autres cancers cutanés liés au soleil (du fait de marqueurs de risque communs).

4.7. Diagnostics différentiels

- Ils sont représentés par :
 - les nævus atypiques ;
 - les kératoses séborrhéiques ;
 - les carcinomes basocellulaires pigmentés ;
 - les histiocytofibromes pigmentés ;
 - les angiomes thrombosés.
- Tous ces diagnostics différentiels ont été définis plus haut. **Dans tous les cas et au moindre doute, l'exérèse doit être réalisée.**

4.8. Traitement de la tumeur primitive

Toute décision thérapeutique est discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et annoncée au patient lors d'une consultation d'annonce.

- Les schémas thérapeutiques sont fonction de l'extension en profondeur (Breslow), de la présence d'une ulcération et d'une éventuelle atteinte ganglionnaire ou à distance (échographie ganglionnaire des aires de drainage, TDM thoraco-abdomino-pelvien, TEP-TDM au 18FDG, TDM ou IRM cérébrale).
- Les mélanomes fins ne nécessitent pas de faire un bilan d'extension initial à la recherche de métastase synchrone (par scanner CTAP ou TEP-TDM).
- Pour tous les mélanomes, le bilan clinique initial comprend un examen de l'ensemble du tégument, la palpation du revêtement cutané de la région et de toutes les aires ganglionnaires.

La classification TNM et le traitement des mélanomes ne figurent pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

Pour plus de précisions sur la classification TNM, voir la classification AJCC 8^e édition.

- Le traitement de la tumeur primitive consiste en une reprise chirurgicale de l'exérèse initiale dont les marges sont conditionnées par l'épaisseur tumorale (**Tableau 2**). Les mélanomes intra-épidermiques de Dubreuilh nécessitent une marge de 1 cm ou une marge de 5 mm avec une technique qui permet une analyse exhaustive des marges.

Tableau 2. MARGES CHIRURGICALES POUR LA PRISE EN CHARGE DU MÉLANOME LOCALISÉ

Épaisseur tumorale (Breslow)	Marges chirurgicales recommandées
<i>In situ</i>	0,5 cm (sauf Dubreuilh)
0 - 1 mm	1 cm
1,01 - 2 mm	1 - 2 cm
> 2 mm	2 cm

- En profondeur, une exérèse emportant toute l'épaisseur de la peau est recommandée (jusqu'au fascia en le respectant).
- La procédure du ganglion sentinelle :
 - est recommandée pour les mélanomes de plus de 1 mm de Breslow sans ganglion identifié ;
 - peut être proposée dans les mélanomes de Breslow 0,8 à 1 mm, quel que soit le statut de l'ulcération et les mélanomes de moins de 0,8 mm ulcérés ;
 - n'a pas d'indication dans les mélanomes de moins de 0,8 mm de Breslow non ulcérés ;
 - doit être précédée si l'indication est retenue d'une échographie ganglionnaire dans le territoire de drainage afin d'éliminer une ou plusieurs métastase(s) ganglionnaire(s) non palpée(s) cliniquement mais détectée(s) à l'échographie (= macrométastase(s), Nxb).

A 4.9. Suivi et prévention

- Les modalités de suivi dépendent du stade de la tumeur (**Tableau 3**).
- La prévention passe par l'information sur les risques des UV, la réduction de l'exposition solaire et la protection solaire, en particulier pendant l'enfance.
- Dans les cas de prédisposition familiale, une surveillance rapprochée doit être mise en place.
- L'auto-dépistage doit être fortement encouragé.

Les modalités du suivi des mélanomes ne figurent pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

Tableau 3. SUIVI EN FONCTION DES STADES

Stade AJCC	Modalités de surveillance
Stade I	Examen clinique tous les 6 mois pendant 3 ans puis annuel à vie Autodépistage et autosurveillance
Stade IA/B	Examen clinique tous les 3 à 6 mois pendant 3 ans puis annuel à vie L'échographie de la zone de drainage pourra éventuellement être utilisée Autodépistage et autosurveillance
Stades IIC/IIIA	Examen clinique complet tous les 3 mois pendant 3 ans, puis tous les 6 mois pendant 2 ans, puis annuel à vie. Autodépistage et autosurveillance. Échographie tous les 3 à 6 mois pendant 3 ans. Scanner CTAP ou 18FDG-TEP-TDM Scan 1 fois/an pendant 3 ans

Stades IIIB/C

Examen clinique complet tous les 3 mois pendant 3 ans, puis tous les 6 mois pendant 2 ans, puis annuel à vie.

Autodépistage et autosurveillance.

Échographie tous les 3 à 6 mois pendant 3 ans.

Scanner CTAP ou 18FDG-TEP-TDM Scan tous les 6 mois pendant 3 ans.

- L'examen clinique complet comprend l'examen de l'ensemble du tégument, la palpation du revêtement cutané de la région et de toutes les aires ganglionnaires.
- Les mélanomes fins ne nécessitent pas de bilan d'extension, notamment par scanner ou TEP-TDM.
- Un traitement adjuvant peut être proposé pour les mélanomes à partir des mélanomes stade IIB.

Principales situations de départ en lien avec l'item 302 :

« Tumeurs cutanées, épithéliales et mélaniques »

Situation de départ	Descriptif
En lien avec la prévention	
303. Prévention/dépistage des cancers de l'adulte	La protection solaire est l'élément essentiel, en particulier en cas de phénotype « clair » : limitation des expositions, protection vestimentaire, couvre-chef, crème anti-solaire qui ne doit pas faire augmenter la durée d'exposition, et à renouveler toutes les 2 heures.
En lien avec les signes et symptômes cliniques	
81. Anomalies des ongles	Penser à un mélanome sous-unguéal.
84. Lésion cutanée / Grains de beauté	Bien connaître les signes en faveur d'un mélanome.
92. Ulcère cutané	Biopsie au moindre doute, notamment sur cicatrice de brûlure ou dans le suivi d'un ulcère variqueux.
En lien avec les données paracliniques	
180. Interprétation d'un compte-rendu anatomo-pathologique	La qualité de l'exérèse chirurgicale est un facteur pronostique majeur. Il faut donc vérifier l'absence d'atteinte tumorale et l'existence de marges suffisamment larges (3 à 10 mm pour les carcinomes, jusqu'à 2 cm pour les mélanomes), y compris en profondeur. Bien que les stratégies thérapeutiques ne soient pas au programme, l'importance prise par les médicaments ciblés (anti-hedgehog dans les carcinomes basocellulaires, anti-EGFR dans les carcinomes épidermoïdes, visant les mutations BRAF dans les mélanomes) et l'immunothérapie (anti-PDL-1, anti-CTLA4) dans les mélanomes peut se traduire par des questions précises concernant l'analyse du prélèvement.
En lien avec la prise en charge aiguë et chronique	
291. Consultation de suivi d'un patient immunodéprimé	Prévoir une consultation annuelle systématique par un dermatologue.
295. Consultation de suivi gériatrique	La fréquence des tumeurs cutanées augmente avec l'âge et les lésions cutanées sont fréquemment négligées par le patient et son entourage. Prendre un avis dermatologique au moindre doute.
297. Consultation de suivi cancérologique	Les récurrences locales sont possibles, surtout en présence de facteurs de mauvais pronostic. Penser aussi à la fréquence des tumeurs multiples synchrones ou asynchrones.

